

☒ ACOMPANHAMENTO () CONSULTA

NS 22231569047 | 677

JOAQUIM DOMINGOS DE MANCILHA

IDADE: 77 PESO: 99 ALTURA: 177 PROFISSÃO: Comerciante
SINTOMAS: cansaço / sonolência / Ronco / Dor de cabeça
QUEIXAS: memória
MEDICAMENTOS: Piran - Rosuvastatina - Forxiga - Selogek
Manipulado - Vit D / Picbam / darix / Firda / Atacant /
MÉDICO: Dr. Cassio Adena max.

MARCAPASSO: () S ☒ N / COMPANHEIRO USA MARCAPASSO: () S ☒ N

EXERCÍCIO FÍSICO: Caminhada

HORARIO DAS REFEIÇÕES - CAFÉ: S ALMOÇO: S LANCHE: S JANTAR:

HORA QUE DORME: 23 HORA QUE ACORDA: 7hs

COCHILLO ☒ SIM () NÃO DORME ACOMPANHADO () SIM ☒ NÃO () EVENTUAL

BEBIDA ALCOÓLICA () SIM () X NA SEMANA NÃO

FUMO () SIM () MAÇO/DIA NÃO - PAROU A QUANTO TEMPO:

TIPO DE RESPIRAÇÃO: nasal BANHEIRO: 5x

CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL: gorda CIRCUNFERÊNCIA PESCOÇO:

OVERLAP: não MALLAMPATI: IV IAH: 65.5 SPO2: 71%

PATOLOGIAS ASSOCIADAS: sente dor de cabeça

CIRURGIAS: () NASAL () AMIGDALECTOMIA Herma Inguinal

HIPOVENTILAÇÃO DA OBESIDADE: Varizes

COMORBIDADE: (N) RESPIRATÓRIA (N) ENDÓCRINA (S) CARDÍACA HAS

(N) ORTOPÉDICA (N) NEUROLÓGICA (N) OUTROS Artrite

14/02 - enviou o relatório relata escape de ar

15/02 - P=8cmH₂O ajustei p/ Pressão fixa

IAH=15.3

m. de uso: 6h40'

fua.

21/02 P=7.0cmH₂O

24 IAH=8.9efev

m. de uso: 6h20'

Boca seca

2x banheiro / bafalava

26/02 P=8.0cmH₂O

24 IAH=9.1efev

m. de uso: 7hr.

melhora da boca

seca.

fua.

20/03 P=8.0cmH₂O

24 IAH=7.8efev

m. de uso: 6h30'

fuga=50.3

fua.

03/05 P=8.0cmH₂O

24 IAH=12.6efev

m. de uso: 5h9'

Fuga=46.2

fua.

08/06 P=8.0cmH₂O

24 IAH=8.7efev

m. de uso: 5h43

fua claudes

22/07 $P = 8 \text{ cmH}_2\text{O}$
24 $\Delta AH = 8.2 \text{ e/lv}$
fuga = 45.2 lpm

Zolpidem 10mg

Jua

30/09 $P = 8 \text{ cmH}_2\text{O}$
24 $\Delta AH = 6.2 \text{ e/lv}$
M. de uso: 7h 9'
fuga: 51.4 lpm

Zolpidem 5mg.

Jua cláudio

02
12
24 $P = 8 \text{ cmH}_2\text{O}$
 $\Delta AH = 5.0 \text{ e/lv}$
M. de uso = 6h 17'
fuga = 50 lpm.

Jua cláudio

03/02
25 $P = 8 \text{ cmH}_2\text{O}$
 $\Delta AH = 5.3 \text{ e/lv}$
M. de uso: 6h 23'
fuga = 50.5 lpm

Jua cláudio

28/05
25 $P = 8 \text{ cmH}_2\text{O}$
 $\Delta AH = 7.6 \text{ e/lv}$
M. de uso: 6h 21'
fuga = 40 lpm.

Jua

Nome: JOAQUIM DOMINGOS DE MANCILHA
Data de Nascimento: 1-9-1946
IMC: 30,97
Sexo: Masculino
Data do exame: 16-12-2023

Peso: 95 kg
Altura: 1,77 m
Médico: DR. JOSÉ CASSIO DE ABREU
Medicamentos:
Histórico:

Laudo de Polissonografia

Exame realizado na noite de 16-12-2023, sendo feita avaliação simultânea de eletroencefalograma, eletrooculograma, eletromiograma (região submentoniana e músculo tibial anterior), posição corporal, fluxo aéreo nasal e oral, esforço respiratório torácico e abdominal, saturação arterial de oxigênio (SpO2) e eletrocardiograma. Os resultados encontram-se em anexo.

O tempo total de registro foi de 572,5 min. As latências de estágio N1 e sono de REM foram, respectivamente, 131,5 e 216,0 minutos. O tempo total de sono foi de 325,0 min, eficiência de 56,8% (normal > 85%) e as porcentagens das fases de sono em relação ao tempo total de sono foram: estágio N1: 3,1%; estágio N2: 66,5%; estágio N3: 6,6%; sono REM: 23,8%. O índice de despertares foi de 26,7/hora (normal < 10/h).

O índice de apnéia/hipopnéia total foi de 65,5/hora, sendo 15 obstrutivas, 0 mistas e 0 centrais e 286 hipopnéias. A SpO2 média foi de 92% e a mínima de 71%, permanecendo 10,3% do tempo de registro com a saturação abaixo de 90%. A frequência cardíaca no estágio REM oscilou entre 59 - 102 bpm e NREM de 53 - 99 bpm.

CONCLUSÃO: Os dados do registro polissonográfico, associados aos do Questionário de Sono e escala de Epworth (09), favorecem as seguintes hipóteses diagnósticas:

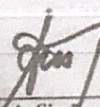
1. Polissonografia demonstrando eficiência do sono reduzida;
2. porcentagem do estágio N3 do sono NREM diminuída e porcentagem do estágio N2 do sono NREM aumentada;
3. índice de apnéia + hipopnéia (IAH) de 65,5/hora;
4. houve dessaturação da oxihemoglobina (min. SaO2=71%);
5. latências para o sono prolongadas;
6. aumento do número de despertares breves;
7. registro de ronco durante o sono.

CPAP

Exame evidenciando apnéia obstrutiva do sono e dessaturação de graus acentuados.

IAH: 05-15 /hora leve.
IAH: 15-30 /hora moderada.
IAH: > 30 /hora acentuada.

Nota: O diagnóstico depende da correlação conjunta com outros fatores.


Dr. José Mario Simões da Costa
Medicina do Sono